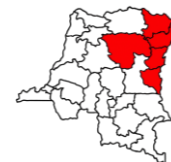




TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Institut National de Santé Publique
Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique
Système de gestion de l'incident MVE17



Rapport de Situation de la 17^{ème} Épidémie de la Maladie à Virus EBOLA /RDC

SitRep N°111/MVEBDB/02/09/2026

Date de rapportage : 02 septembre 2026

Date de publication : 03 septembre 2026



FAITS SAILLANTS (dernières 24h)

Au cours des dernières 24h, **92 nouveaux cas confirmés** dont **24 décès communautaires** de la Maladie à Virus Ebola (MVE) ont été enregistrés dans les provinces de l'Ituri (60 cas), du Nord-Kivu (25 cas), Haut Uélé (5) et (2) à la Tshopo. De plus, **9 décès intra-CTE** ont été enregistrés.

Aucune nouvelle zone de santé touchée au cours de dernières 24h avec une notification globale en hausse (+53,1 %)

CUMUL DES CAS 6 342	CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS 3 072	LETALITE 48,4%	PATIENS EN ISOLEMENT/CTE 770	CUMUL DES GUÉRIS 1 475	TAUX DE SUIVI DES CONTACTS (Du Jour) 86,5 %
--	--	-------------------------------------	---	---	--



Provinces touchées et Zones de santé touchées



6 Provinces touchées

Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tshopo & Bas Uélé



60 Zones de santé touchées sur 151

(39,7%)



Résumé des points clés au cours de dernières 24 heures

Au cours des dernières 24 heures, **92 nouveaux cas confirmés** dont **24 décès communautaires** de la Maladie à Virus Ebola (MVE) ont été notifiés dans les provinces de l'Ituri (**60 cas**), Nord-Kivu (**25**), Haut Uélé (**5**) et Tshopo (**2**). De plus, **9 décès intra-CTE** ont été enregistrés, dont 6 en Ituri, 2 au Nord-Kivu et 1 au Haut Uélé, portant le **nombre des décès du jour à 33**.

Cependant, **36 patients** ont été déclarés guéris après avoir obtenu deux résultats négatifs à la MVE (28 en Ituri, 6 au Nord-Kivu et 2 au Haut Uélé).

Au 02 septembre 2026, la RDC totalise **6 342 cas confirmés** dont **3 072 décès**, soit une létalité de **48,4 %**. La province de l'Ituri demeure l'épicentre avec **81,4 %** des cas confirmés enregistrés au pays et détient **65,2 %** des nouveaux cas confirmés rapportés au cours des dernières 24h.

Depuis le début de l'épidémie en RDC, **60 zones de santé sur 151 (39,7%)** restent affectées à travers les six provinces touchées. L'Ituri compte 28 zones de santé touchées sur 36, suivi du Nord-Kivu (15/34) du Haut-Uélé (6/13), de la Tshopo (7/23), du Sud-Kivu (1/34) et Bas Uélé (3/11).

Tableau 1. Répartition des cas et décès confirmés par province touchée, au 02 septembre 2026.

Province	Nouveaux cas confirmés(24h)	Cas confirmés	Décès (confirmés)	Létalité	Zones de santé touchées
Ituri	60	5164	2 342	45,4%	28/36 (77,8 %)
Nord-Kivu	25	913	614	67,3%	15/34 (44,1 %)
Haut-Uélé	5	236	103	43,6%	6/13 (46,1 %)
Tshopo	2	22	9	40,9%	7/23 (30,4 %)
Sud-Kivu	0	3	1	33,3%	1/34 (2,9 %)
Bas Uélé	0	4	3	75,0%	3/11(27,3%)
Total	92	6 342	3 072	48,4%	60/151 (39,7 %)

Tableau 2. Répartition des cas et décès confirmés par province et zone de santé, au 02 septembre 2026

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. Cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	5164	2342	45,4%	60	12	6	18
Adja	11	1	9,1%				0
Aru	8	6	75,0%				0
Ariwara	8	2	25,0%				0
Aungba	12	5	41,7%				0
Bambu	168	36	21,4%	3	0		0
Boga	2	2	100,0%				0
Bunia	1444	447	31,0%	31	5		5
Damas	28	9	32,1%				0
Drodro	14	7	50,0%				0
Fataki	77	30	39,0%				0
Gethy	6	2	33,3%				0
Kambala	2	0	0,0%				0
Kilo	32	12	37,5%				0
Komanda	92	62	67,4%				0
Lita	225	121	53,8%	1	0		0
Logo	11	5	45,5%				0
Lolwa	22	5	22,7%				0
Mahagi	4	1	25,0%				0
Mambasa	17	7	41,2%				0
Mandima	36	21	58,3%				0
Mangala	271	138	50,9%	8	4		4
Mongbwalu	616	288	46,8%	1	1		1
Nia-Nia	218	113	51,8%	2	0		0
Nizi	675	266	39,4%	5	2		2
Nyankunde	124	35	28,2%				0
Rimba	11	4	36,4%				0
Rwampara	971	341	35,1%	7	0		0

Tchomia	59	25	42,4%	2	0		0
A ventiler	NA	351	NA	NA	NA	6	6
Nord-Kivu	913	614	67,3%	25	11	2	13
Beni	151	109	72,2%	5	3	1	4
Biena	1	1	100,0%				0
Butembo	186	134	72,0%	6	0		0
Goma	1	0	0,0%				0
Kalunguta	16	7	43,8%				0
Katwa	416	278	66,8%	8	7	1	8
Kyondo	16	12	75,0%				0
Lubero	4	3	75,0%	1	0		0
Mabalako	7	5	71,4%	1	0		0
Manguredjipa	2	1	50,0%				0
Masereka	12	5	41,7%	1	0		0
Musienene	85	48	56,5%	2	1		1
Mutwanga	2	2	100,0%				0
Oicha	8	6	75,0%	1	0		0
Vuhovi	6	3	50,0%				0
Haut-Uélé	236	103	43,6%	5	1	1	2
Boma Mangbetu	27	14	51,9%				0
Gombari	3	1	33,3%				0
Isiro	86	35	40,7%	1	1		1
Pawa	39	22	56,4%	2	0		0
Rungu	2	1	50,0%	1	0	1	1
Wamba	79	30	38,0%	1	0		0
Tshopo	22	9	40,9%	2	0	0	0
Bafwasende	2	0	0,0%				0
Kabondo	4	1	25,0%	1	0		0
Lubunga	1	0	0,0%				0
Makiso-Kisangani	10	5	50,0%	1	0		0
Mangobo	3	2	66,7%				0
Tshopo	1	0	0,0%				0
Wanie-Rukula	1	1	100,0%				0
Sud-Kivu	3	1	33,3%	0	0	0	0
Miti-Murhesa	3	1	33,3%				0
Bas Uélé	4	3	75,0%	0	0	0	0
Buta	1	1	100,0%				0
Viadana	1	0	0,0%				0
Ganga	2	2	100,0%				0
Total	6342	3072	48,4%	92	24	9	33

*Il s'agit des décès confirmés survenus dans les différents CTE de la province et sont en cours de ventilation pour être classifié par zone de santé.

NA : Non Applicable.

** Ces décès ont été enregistrés dans les différents CTE de la province de l'Ituri et sont en cours de ventilation.

Tableau 3. Situation des alertes notifiées par province, au 02 Septembre 2026

DPS	Nouvelles Alertes Reçues		Total alertes	Alertes vérifiées et validées (cas suspect)		Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect)		Nombre de suspects investigués	Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour)
	Vivants	Décédés		Vivants	Décédés	Vivants	Décédés		
Haut-Uélé	24	6	30	21	6	3	0	27	15
Bas Uélé	33	1	34	5	1	28	0	6	0
Ituri	900	66	966	140	66	746	0	206	119
Nord-Kivu	1 374	74	1448	123	57	1251	17	180	100
Sud-Kivu	13	0	13	5	0	1	0	5	4
Tshopo	118	1	119	9	0	106	0	9	2
Total Général	2462	148	2 610	303	130	2135	17	433	240

Figure 1. Évolution de cas par date de début des symptômes au cours de 21 derniers jours

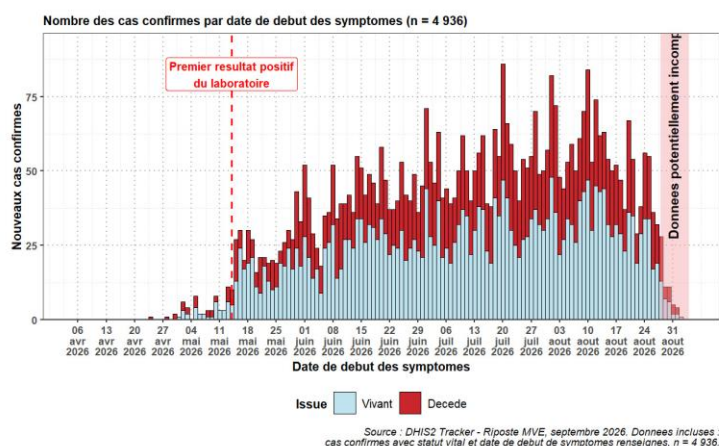
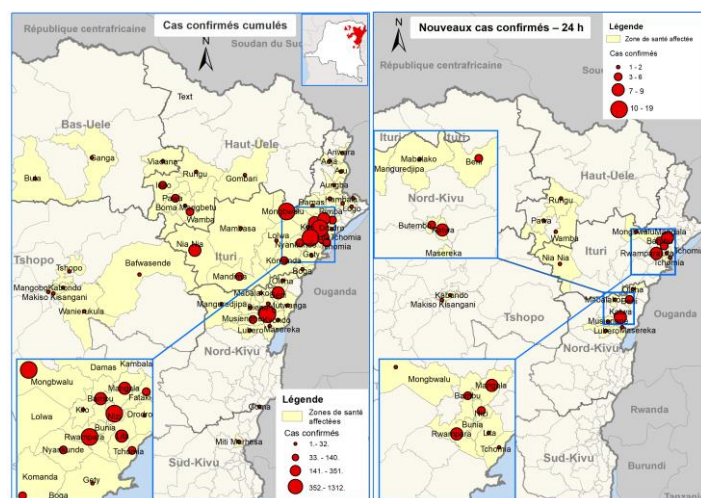


Figure 2. Distribution spatiale des cas confirmés (24h et cumuls) par zone de santé.



1. COORDINATION

1.1. Principales Actions

- Suivi et accompagnement des actions de la réponse dans toutes les provinces touchées.

2. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

1.1.1. Surveillance épidémiologique

1.1.2. Principales Actions

Au décours de la journée du 02 septembre 2026, 2 610 alertes ont été enregistrées dans les 6 provinces touchées, 2 585 (99,0%) ont été vérifiées. À l'issue de cet exercice, 433 alertes ont été validées comme cas suspects. Ces derniers ont tous été investigués (100 %) et 240 d'entre eux ont été transférés vers les CT/CTE (Tableau 3).

S'agissant des contacts suivis au cours des dernières 24 heures, la proportion se situe à 86,5 % (17 910 vus sur 20 711 à suivre) moins que la veille (89,0%) mais demeure supérieure au seuil de 85 % ; 59,8 % à la Tshopo (211/353), 84,9% au Nord-Kivu (7 674/9 034), 89,8% en Ituri (9 310/ 10 371), 80,0% au Haut Uélé (471/589) et 67,0% au Bas Uélé (244/364). Les données de la ZS de Wamba (province de la Tshopo) n'ont pas été rapportées.

1.1.3. Défis

Persistance d'un faible suivi des contacts autour des cas confirmés dans la province du Bas Uélé, lié à une insuffisance des équipes dédiées à ces activités.

1.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoC/PoE)

1.2.1. Principales actions

Neuf (09) alertes vivantes ont été notifiées aux différents PoE/PoC en date du 02 septembre 2026, dont deux validées : une en Ituri, au PoC de Dele (ZS Rwampara), isolée mais ayant refusé le transfert au CTE ; une au Haut-Uélé, au PoC de Magambe (ZS Isiro), interceptée, validée et référée au CTE. Les trois alertes du Nord-Kivu et les quatre du Bas-Uélé ont été invalidées.

Tableau 4. Situation indicateurs clés des PoC/PoE par province, en date du 02 Septembre 2026

Indicateurs	Ituri	Nord-Kivu	Sud-Kivu	Tshopo	Haut-Uélé	Bas-Uélé	Global
Complétude des rapports	85 % (51/60)	100 % (18/18)	55,5 % (5/9)	83 % (15/18)	64 % (7/11)	ND	82,8 % (96/116)
% des PoE/PoC stratégiques fonctionnels	9,1 % (1/11)	NA	NA	NA	NA	NA	9,1 % (1/11)
Nombre de personnes passées aux PoE/PoC	128 104	87 136	8 848	13 299	9 890	5 250	252 527
% des voyageurs screenés	97,49%	97,66%	98,87%	100%	98,86%	98,00%	97,80%
% des voyageurs ayant lavé les mains	98,08%	97,66%	98,87%	98,56%	95,17%	ND	97,87%
% des voyageurs sensibilisés	99,62%	97,66%	100%	100%	95,56%	ND	98,80%
Nombre d'alertes notifiées	1	3	0	0	1	4	9
Nombre d'alertes vivantes validées (cas suspects)	1	0	0	0	1	0	2
Nombre de corps sans vie interceptés ce jour	0	0	0	0	0	0	0
% des cas suspects transférés au CT/CTE	0% (0/1)	NA	NA	NA	100% (1/1)	NA	50% (1/2)
% des corps sans vie swabés/sécurisés	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
% des cas suspects investigués dans 24 h	100% (1/1)	0	NA	NA	100% (1/1)	0	(2/2) 100%

1.2.2. Défis

Opérationnalisation des PoE/PoC non optimale et faible complétude de rapportage au Sud-Kivu (55,5 %) et au Haut-Uélé (64,0 %) ; En Ituri, 1 (9,09 %) des 11 PoE/PoC stratégiques demeure fonctionnel sans interruption : le PoC d'Avakubi est non fonctionnel pour raisons sécuritaires, les PoC Nzebi, Frigo, Galay, Pont Ituri, Makoko 2, Mabakese, Bey et Foner Mambasa sont en grève faute de paiement. Au Haut-Uélé, 4 PoC (Dusu, Apodo, PK6 route Niangara et Gossamu) n'ont pas rapporté et le PoC de Magambe enregistre des refus élevés de lavage des mains (12 %). Au Sud-Kivu, l'absence de dispositif d'isolement aux PoE de Kavimvira, Kalundu Port SNCC et Baraka demeure. Au Bas-Uélé, l'insuffisance de mobilité, de connectivité et d'approvisionnement en eau aux PoE/PoC persiste

1.3. Laboratoire

1.3.1. Principales actions

- **Ituri : 60 nouveaux résultats positifs** (48 vivants et 12 décès) sur 267 nouveaux échantillons reçus et analysés (**positivité : 22,5 %**).
- **Nord-Kivu : 25 nouveaux résultats positifs** (14 vivants et 11 décès) sur 110 échantillons analysés (**positivité de 22,7%**).

- **Haut-Uélé : 5 nouveaux résultats positifs** (4 vivants dont 1 décès) sur 21 échantillons analysés (**positivité : 23,8%**).
- **Bas-Uélé : 4 échantillons** reçus et testés (4 sangs), tous sont revenus négatifs.
- **Tshopo : 2 nouveaux résultats positifs** (2 vivants) sur 6 échantillons analysés (**positivité : 33,3%**).

1.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

1.4.1. Principales actions

- **En Ituri**, 18 rings ont été ouverts sur les 55 identifiés (32,7 %), 133 ménages décontaminés sur 143 identifiés (93,0 %) et 11 FOSA sur 11 (100 %) ; 72 EDS réalisées sur 91 alertes et 56 corps swabés.
- **Au Nord-Kivu**, 19 rings ouverts sur 38 (50,0 %), 14 ménages décontaminés sur 35 identifiés (40,0 %) et 34 FOSA décontaminées sur 39 (87 %) ; 6 évaluations FOSA réalisées avec un score moyen de 29 %. D'autre part, 64 corps swabés et 59 EDS réalisés.
- **À la Tshopo**, poursuite décontamination de 6 locaux, 1 latrine et 1 douche de PEKIS (17è cas) ; suivi et accompagnement de 11 ESS dans 5 ZS (Makiso-Kisangani, Mangobo, Tshopo, Kabondo et Lubunga) au cours desquels 116 prestataires ont été briefés sur la mise en œuvre des mesures PCI ; décontamination de 6 locaux, 1 latrine et 1 douche à PEKIS et mise en place d'un système de dépistage et de triage à l'HGR Bafwasende.

1.4.2. Au Bas-Uélé, évaluation de l'HGR de la ZS de Ganga (score : 21,3 %) et 1 corps swabé dans la ZS de Ganga.

1.4.3. Défis

- Faible mise en œuvre des normes de PCI : en Ituri, l'ouverture des rings demeure faible (32,7 %, 18/55) ; insuffisance d'équipes de décontamination à Fataki, Mangala et Nizi. Au Nord-Kivu, seuls 14 ménages ont été décontaminés sur 35 identifiés (40,0 %). Au Bas-Uélé, aucun ring ouvert et aucun ménage décontaminé sur les 2 identifiés, 5 ZS restant non formées en PCI (Aketi, Bondo, Likati, Monga et Bili). À la Tshopo, insuffisance d'intrants PCI dans les ESS et panne de l'incinérateur de l'HGR Makiso-Kisangani.

1.5. Prise en charge holistique

1.5.1. Principales actions

- **En Ituri**, 63 nouvelles admissions dans les différentes structures dédiées contre 106 sorties dont 28 guéris. Ainsi, 434 patients sont hospitalisés pour 978 lits, soit un taux d'occupation de 44,4 %.
- **Au Nord-Kivu**, 73 nouvelles admissions et 50 sorties enregistrées dont 6 guéris ; 261 patients sont hospitalisés et le taux d'occupation global des lits en CTE/CT est en sursaturation (118,6 % ; 220 lits disponibles).
- **Au Haut Uélé**, 9 nouvelles admissions ont été enregistrées. Au terme de la journée, 56 patients, soit un taux d'occupation global de 46,7% (120 lits).
- **À la Tshopo**, 3 nouvelles admissions ont été enregistrées. Sept (7) patients sont en isolement pour 25 lits, soit un taux d'occupation global de 28,0%.

1.5.2. Défis

Faible capacité d'accueil et saturation : en Ituri, le CTE de Nizi est saturé pour les suspects ; au Nord-Kivu, sursaturation des CT/CTE (118,6 %), certains patients sont pris en charge dans des ESS non dédiés ; au Bas-Uélé, absence de CTE/CT normé et d'ambulance ; à la Tshopo, absence de CTE normé à Bafwasende et indisponibilité en poches de sang.

1.6. Communication sur les risques et engagement communautaire

1.6.1. Principales actions

- **En Ituri**, Appuis de la CREC à l'EDS autour de 52 décès communautaires dans 10 zones de santé de l'Ituri notamment Nizi, Mongbwalu, Bambu, Fataki, Mangala (Territoire de Djugu),

Bunia, Komanda, Rwampara (Territoire d'Irumu) Nia-Nia (Territoire de Mambasa), Tchomia (en cheval entre Djugu et Irumu). Aru (Territoire d'Aru) ; Plaidoyer auprès du président district CE39 Songolo (Zone de Santé de Gety) ; Chef de Groupement Plutô (Zones Santé de Mongbwalu).

- **Au Nord-Kivu**, 6 033 visites à domicile ont été réalisées touchant 19 680 personnes ; 83 causeries éducatives réalisées avec 3 142 personnes ; 1 briefing (100 personnes), 1 plaidoyer et 2 dialogues communautaires (102 personnes) ; 11 feedbacks et infodémies résolus dans les 48 heures sur 15 captés et 281 alertes notifiées par les acteurs communautaires.
- **À la Tshopo**, 3 634 personnes sensibilisées (1 978 femmes et 1 656 hommes) ; 2 rumeurs clarifiées et 2 feedbacks communautaires recueillis ; 514 dépliants, 78 affiches et 4 banderoles distribués ; appui au lancement des journées locales de vaccination contre la polio au rond-point du Pont Tshopo, avec 2 720 personnes sensibilisées ; formation des leaders communautaires des AS Lundi et Kenge (ZS Bafwasende).
- **Au Bas-Uélé**, 1 278 personnes ont été sensibilisées dans les structures de santé et auprès des femmes enceintes ; briefing de 50 représentants des motards de Buta ; ronde d'évaluation du lavage des mains dans les écoles de Buta ; démonstration de préparation du chlore dans les écoles de la ZS de Bili ; appui à la surveillance à base communautaire dans la ZS de Monga et émission interactive sur la radio Rubi de Buta.

1.6.2. Défis

Persistance des défis au niveau communautaire : en Ituri, 21 refus d'isolement au CTE, 11 corps non swabés pour résistance communautaire et résistances à Rwampara, Nyankunde, Bunia, Tchomia, Lita, Mangala et Kilo ; à la Tshopo, résistances aux investigations, aux prélèvements, à l'isolement et au transfert au CTE.

1.7. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

1.7.1. Principales actions

- **En Ituri**, 16 personnes parmi les nouveaux cas confirmés et 143 des 176 cas confirmés en cours de suivi (81,2 %) ont bénéficié d'interventions SMSPS ; 27 des 63 nouveaux suspects (42,8%) ; 68 ménages accompagnés, 60 PPL soutenus, 64 annonces de résultats dont 16 positifs et 16 guéris sur 17 suivis en communauté (94%).
- **Au Nord-Kivu**, 18 nouveaux cas confirmés et 89 des 108 cas suspects ont bénéficié d'interventions SMSPS ; 103 des 123 annonces de résultats réalisées dont 20 positifs, 68 PPL soutenus et 40 ménages accompagnés. À la Tshopo, 2 cas confirmés et 2 Cas suspects en cours de suivi 3 annonces de résultats dont 2 positifs et 6 accompagnants soutenus au CT ; 2 guéris ont intégré les équipes de riposte.

1.7.2. Défis

En Ituri, faible couverture des interventions SMSPS autour des derniers cas confirmés ; couverture limitée à 5 des 9 ZS ayant notifié (55,6 %).

1.8. Logistique

1.8.1. Principales actions

- **En Ituri**, début des travaux d'aplanissement du site du CTE de Mangala et organisation des transferts inter-CTE.
- **Au Nord-Kivu**, visite conjointe des CTE de Katwa, Beni et Matanda et prospection du terrain destiné au futur centre de traitement de Musienene, avec la PEC médicale, l'OMS, le PAM et l'UNICEF.
- **Au Bas-Uélé**, appui au déploiement de l'équipe de surveillance pour le suivi des contacts, la vérification des alertes et la recherche active, et poursuite de la vaccination des PPL et TPL dans la ZS de Buta.

1.8.2. Sécurité

1.8.3. Principales actions

- **Au Nord-Kivu**, 9 activités de maintien de la discipline populaire ont été réalisées, dont l'accompagnement sécuritaire des équipes PCI pour les décontaminations à Beni (AS Malepe, Butsili et Mukulya) et des équipes EDS pour les inhumations de 4 cas confirmés aux cimetières de Mankizo et de Bundji.

1.8.4. Défis

Vingt-un (21) refus d'isolement au CTE signalés en Ituri. Au Nord-Kivu, résistance des officiels au respect du protocole sanitaire aux PoC et sécurisation renforcée du PoC de Vulindi (ZS Butembo).

1.9. PSEA (Prévention contre l'Exploitation et les Abus Sexuels)

1.9.1. Principales actions.

En Ituri, poursuite de la formation sur la prévention contre les exploitations, abus et harcèlement sexuel dans les différentes provinces touchées.

1.9.2. Défis

- Couverture encore insuffisante des activités PSEA : 25 % des zones de santé de l'Ituri (9/36) connaissent le mécanisme de signalement ; absence de cartographie des intervenants ; insuffisance de supports de sensibilisation de masse ; manque de moyens de transport et d'équipement informatique pour le pilier.

MESSAGES CLÉS

- La transmission continue de la MVE, avec **92 nouveaux cas confirmés** dont **24 décès communautaires et 9 intra-CTE** enregistrés au cours des dernières 24 heures, portant le cumul national à **6 342 cas confirmés et 3 072 décès**.
- Un maintien des performances s'observe dans les investigations épidémiologiques (**100 % des cas suspects investigués**) et une stabilité de la proportion journalière du suivi des contacts (**86,5%**) qui demeure supérieur au seuil de 85,0%.
- L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, concentrant 81,4 % des cas confirmés cumulés et 65,2% des nouveaux cas rapportés au cours des dernières 24 heures, suivi de la province du Nord-Kivu qui affiche la létalité la plus élevée.
- Le renforcement des interventions prioritaires (surveillance, prise en charge, PCI, logistique et engagement communautaire) demeure essentiel pour interrompre rapidement les chaînes de transmission.

CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17^e épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.
- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des fonds.



TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Institut National de Santé Publique
Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique
Système de gestion de l'incident MVE17

Directeur Général de l'INSP

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

E-mail : dieudonne.mwamba@insp.cd

Incident Manager

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve

E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

Chargé des opérations

Dr Kombe NGWAMA John

Equipe rédaction

Professeur Dr Mulangu Katulumba Félix-Médard

Dr Katusi Biselenge Jules

Madame Mayele Afua Marie

Dr Diur Mananashi Floryan

Mr Kamuina Kebela John

Contact :

www.insp.cd

contact@sgiebola17.org

Numéro vert : 151. www.sante.gouv.cd